



Entregable 2

Caso clínico 7

Grupo 12



DATOS PERSONALES:

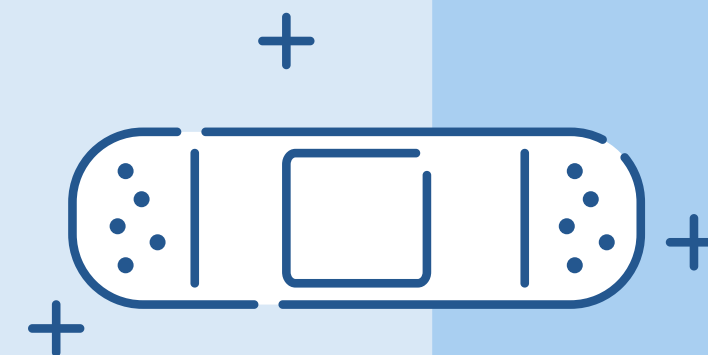
NOMBRE: LSA

Edad: 21 años

Procedencia: Lima

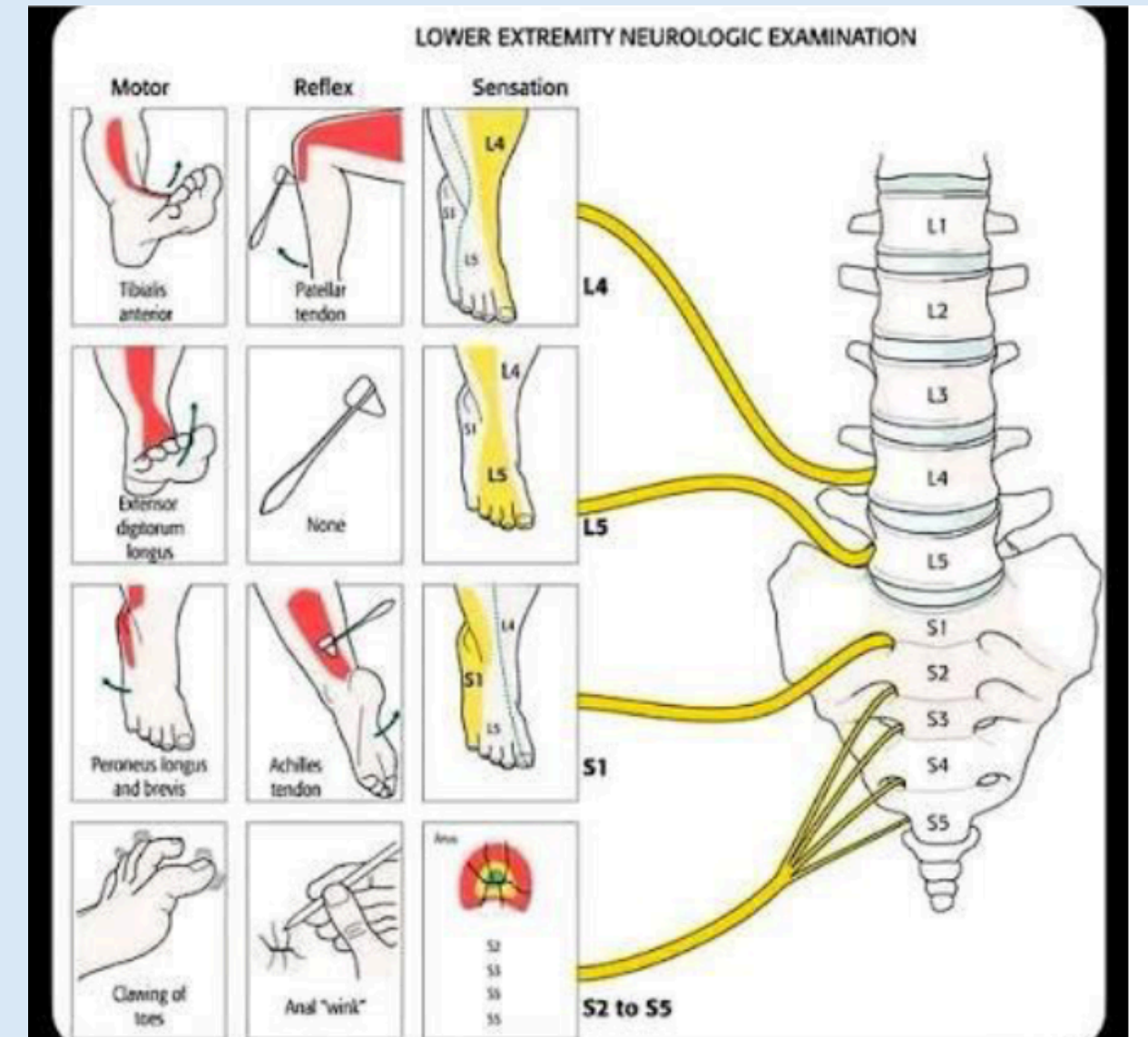
Motivo de ingreso: Rehabilitación integral

- Locomoción independiente en silla de ruedas mecánica simple.
- Independencia en actividades de la vida diaria.
 - Reeducación esfinteriana.
- Prevención de complicaciones.
 - Adaptación psicosocial.
- Orientación sexual individual.



Estado del paciente

RIGHT				MOTOR KEY MUSCLES			SENSORY KEY SENSORY POINTS			SENSORY KEY SENSORY POINTS			MOTOR KEY MUSCLES			LEFT		
				Light Touch (LTR)			Pin Prick (PPR)			Light Touch (LTL)			Pin Prick (PPL)					
C5-C8 T1-T12	C2	2	2															
	C3	2	2															
	C4	2	2															
	C5	5	2	2											5	C5 Elbow flexors		
	C6	5	2	2										5	C6 Wrist extensors			
	C7	5	2	2										5	C7 Elbow extensors			
	C8	5	2	2										5	C8 Finger flexors			
	T1	5	2	2										5	T1 Finger abductors (little finger)			
	T2	2	2	2										2				
	T3	2	2	2										2				
	T4	2	2	2										2				
	T5	2	2	2										2				
T6	2	2	2										2					
T7	2	2	2										2					
T8	2	2	2										2					
T9	2	2	2										2					
T10	2	2	2										2					
T11	2	2	2										2					
T12	1	2	2										1					
L1	0	0	0										0					
L2	0	0	0										0					
L3	0	0	0										0					
L4	0	0	0										0					
L5	0	0	0										0					
S1	0	0	0										0					
S2	0	0	0										0					
S3	0	0	0										0					
S4-5	2	2	2										2					
RIGHT TOTALS (MAXIMUM)				25	39	36	LEFT TOTALS (MAXIMUM)				25	38	38					
				(50)	(56)	(56)					(50)	(56)	(56)					
SENSORY SUBSCORES Light Touch (LTR) 39 + LTL 38 = LT TOTAL 77 (112) Pin Prick (PPR) 36 + PPL 38 = PP TOTAL 74 (112)																		
MOTOR SUBSCORES C5-C8: 5 + 5 + 5 + 5 = 20 (25) T1-T12: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 24 (25) L1-L5: 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0 (5) S1-S3: 0 + 0 + 0 = 0 (5) S4-5: 2 + 2 = 4 (5)																		
NEUROLOGICAL LEVEL OF INJURY (NLI) 1. SENSORY: T9 2. MOTOR: T9 3. NEUROLOGICAL LEVEL OF INJURY (NLI): T9																		
COMPLETE OR INCOMPLETE? 4. COMPLETE OR INCOMPLETE? Incomplete = Any sensory or motor function in S4-5 5. ASIA IMPAIRMENT SCALE (AIS): B																		
ZONE OF PARTIAL PRESERVATION 6. ZONE OF PARTIAL PRESERVATION: NA																		



0	0	L2 <i>Hip flexors</i>
0	0	L3 <i>Knee extensors</i>
0	0	L4 <i>Ankle dorsiflexors</i>
0	0	L5 <i>Long toe extensors</i>
0	0	S1 <i>Ankle plantar flexors</i>

Usuario/Paciente: Habilidades y capacidades de la persona con discapacidad

Estado neuromuscular y musculoesquelético

- Pérdida de movimiento/sensibilidad en miembros inferiores (paraplejia)
- POSTURA: Control del tronco le permite tener estabilidad en su silla de ruedas
- CONTROL MOTOR:
Fuerza y manejo completo de miembros superiores (intactos):
 - Propulsión en silla de ruedas ✓
 - Traslados/cambios de posición ✓
 - Movimientos adaptativos con brazos ✓
- INFLUENCIA NEUROLÓGICA:
Algunos reflejos conservados en miembros inferiores:
 - ROT patelar izq.: Disminuido
 - Reflejo aquileo bilateral
 - Reflejo perianal

*No hay contracción voluntaria del esfínter anal
- MUSCULATURA: Disminuida en miembros inferiores

Usuario/Paciente: Habilidades y capacidades de la persona con discapacidad

Estado neuromuscular y musculoesquelético

- PERCEPCIÓN SENSORIAL: Ausente en miembros inferiores y S4-S5 (región sacra).
 - Mayor propensión a sufrir lesiones por presión de no tomar cambios posturales
- **Dolor/molestias en espalda o brazos por mecanismos adaptativos**

Desempeño funcional

- Tiene cierta independencia en sus actividades, requiere asistencia parcial
 - Alimentación ✓
 - Vestirse ✓
 - Traslados ✓
- Rutina y actividades físicas: Adopta posturas recomendadas y

Usuario/Paciente: Habilidades y capacidades de la persona con discapacidad

Desempeño funcional

- ASEO Y MANEJO DE EVACUACIONES: Se realiza cateterismo intermitente y se determina una rutina con horarios para evacuaciones. De ser necesario, se utilizan métodos como el enema.

Afecciones a la piel

- Antecedente de lesión por presión

Estado psicosocial

- Está completamente lúcido
- Puede comunicarse
- Nivel cognitivo y articulación no afectados
- Apoyo por parte de la familia
- **Conciencia de seguridad**

Guía Técnica: Protocolo de Atención en Rehabilitación Integral de la Lesión de la Médula Espinal



Evaluación Integral Multidisciplinaria

Clasificación neurológica (ASIA), evaluación del tono muscular, evaluación articular, función respiratoria, control postural

Análisis de criterios para la Selección de Ejercicios

Nivel de Lesión (tetraplejía y paraplejía), Fase de rehabilitación, preservación motora

Aplicación Práctica del Programa de Ejercicios

Diversas categorías (reeducación respiratoria, movilización, fuerza y resistencia, destrezas)

Prevención y Educación para el Hogar

Reinserción a la vida cotidiana

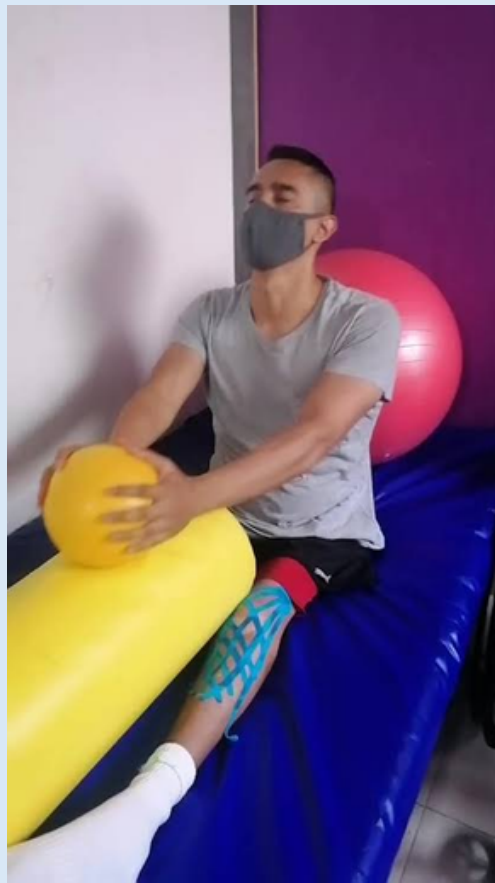


ACTIVIDAD

Desempeño funcional

CONTROL POSTURAL

Ejercicios funcionales que
favorezcan al equilibrio de tronco



FORTALECIMIENTO DE EXTREMIDADES SUPERIORES



Remo sentado con banda
Pulsaciones con silla de ruedas

TÉCNICAS DE TRANSFERENCIA



VIDA COTIDIANA



- Vestirse
- Comer
- Cuidado personal



- Bañarse
- Usar el inodoro
- Subir las escaleras



- Ir al baño
Reeducación intestinal



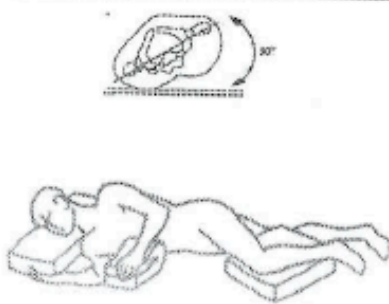
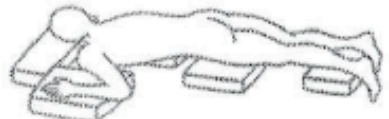
Horario de Evacuación

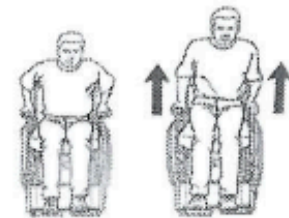
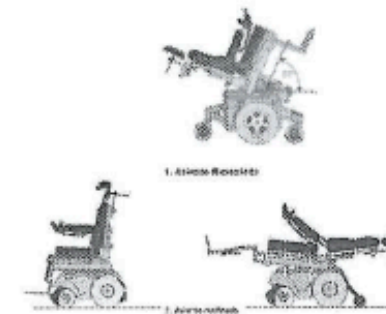
- Cateterismo

ÚLCERAS POR PRESIÓN

- Tareas diarias:
- Cambios posturales frecuentes
 - El uso del espejo
 - Colocación de almohadillas
 - Liberación de zonas de presión

Antecedente: Úlcera por presión grado III y colgajo

DECUBITO SUPINO - Las piernas deben quedar ligeramente separadas y rodillas ligeramente flexionadas - Los pies y manos deben conservar su posición funcional. - Evitar rotación del trocánter. Colocar almohadas: ✓ Debajo de la cabeza ✓ Debajo de la cintura ✓ Debajo de los muslos ✓ Debajo de las piernas ✓ Apoyando la planta del pie.	
DECUBITO LATERAL - La espalda quedará apoyada en la almohada formando un ángulo de 30-45° - La pierna inferior estirada y la superior flexionada. - Extremidades superiores flexionadas - Evitar apoyar todo el peso en trocánter. Colocar almohadas: ✓ En la espalda ✓ Entre las piernas (de ingles a pies) para evitar rotación interna de cadera ✓ Bajo el brazo superior para evitar rotación interna de hombro.	
DECUBITO PRONO - Debe quedar libres de presión: cresta ilíaca, rodillas, genitales, mamas y 1° dedo pies. - El tórax debe de quedar libre para respirar con comodidad. - Está contraindicada en pacientes con lesiones torácicas, cardíacas y con respiración asistida. Colocar almohadas: ✓ Debajo de los muslos ✓ Debajo del abdomen ✓ Debajo de las piernas	

SEDENTE EN SILLA DE RUEDAS Pulsión: Es la maniobra más conocida, pero también la más difícil. Consiste en extender los brazos y levantar las nalgas para que no se apoyen en la silla. Solo la pueden realizar lesionados C7 o inferiores, y necesitan mucha fuerza en los brazos para realizarla.	
Lateralización: Consiste en inclinar por completo el tronco, primero hacia un lado y después hacia el otro. Podemos retirar el reposabrazos del lado hacia el que nos inclinemos para liberar correctamente la presión.	
Flexión anterior: Hay que flexionar el tronco hasta tocar las rodillas con el pecho	
Báscula posterior de la silla de ruedas: La suele realizar un asistente. También se puede apoyar la silla contra una pared, recordando siempre frenar las ruedas.	
Cambios posturales en sillas con motor: Las sillas con motor pueden facilitar los cambios posturales al bascular el asiento (entre 30 y 65°) o reclinar el respaldo. Esto es útil sobre todo en las personas que no pueden cambiar de postura por sí mismas.	

Movilidad personal y Adaptaciones

Uso permanente de silla de ruedas



HOGAR



EXTERIOR



05



Actividades del hogar y trabajo.
Un antes y un después del accidente.



06



Barreras
infraestructurales
del paciente en su
entorno diario



RESPUESTAS OBTENIDAS

- Manejo de evacuaciones: Se realiza una reeducación intestinal estableciendo un horario fijo diario en el inodoro. Si no hay éxito, se estimula con agua, dieta (pitahaya), enemas o tacto rectal.
- Cateterismo: El paciente realiza su propio autocateterismo de forma independiente usando técnica limpia, con una frecuencia de 2 a 3 veces al día.
- Ejercicios para transferencias: Se basan en ejercicios funcionales para ganar equilibrio en el tronco y en la práctica directa de pasar de la silla a la cama, al inodoro y al auto.
- Tratamiento de rigidez y contracturas: Se maneja mediante fisioterapia con movimientos pasivos en las piernas, medicación para el tono muscular y el uso de agentes físicos (láser, electrodos, magnetoterapia y punción con agujas).

Tecnología:

Dispositivos:



Silla de ruedas estándar



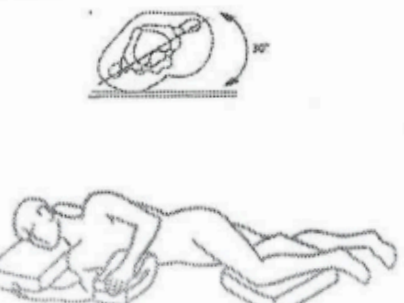
Cojín de espuma prensada, espuma viscoelástica y cojín de glicina

Estrategias:



- **Entrenamiento de autoinspección de la piel mediante el uso del espejo.**
- **Reeducación en la descompresión y cambios posturales.** El paciente mismo se acuerda de hacer la liberación de presión. Como mínimo 10 veces al día.
- **Reconocimiento temprano de signos de una UPP.**

PROGRAMA EDUCATIVO DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ÚLCERA POR PRESIÓN

DECUBITO SUPINO - Las piernas deben quedar ligeramente separadas y rodillas ligeramente flexionadas - Los pies y manos deben conservar su posición funcional. - Evitar rotación del trocánter. Colocar almohadas: ✓ Debajo de la cabeza ✓ Debajo de la cintura ✓ Debajo de los muslos ✓ Debajo de las piernas ✓ Apoyando la planta del pie.	
DECUBITO LATERAL - La espalda quedará apoyada en la almohada formando un ángulo de 30-45° - La pierna inferior estirada y la superior flexionada. - Extremidades superiores flexionadas - Evitar apoyar todo el peso en trocánter. Colocar almohadas: ✓ En la espalda ✓ Entre las piernas (de ingles a pies) para evitar rotación interna de cadera ✓ Bajo el brazo superior para evitar rotación interna de hombro.	
DECUBITO PRONADO Pulsión: Es la maniobra más conocida, pero también la más difícil. Consiste en extender los brazos y levantar las nalgas para que no se apoyen en la silla. Solo la pueden realizar lesionados C7 o inferiores, y necesitas mucha fuerza en los brazos para realizarla. Lateralización: Consiste en inclinar por completo el tronco, primero hacia un lado y después hacia el otro. Podemos retirar el reposabrazos del lado hacia el que nos inclinemos para liberar correctamente la presión. Flexión anterior: Hay que flexionar el tronco hasta tocar las rodillas con el pecho	



Gracias